

Czym jest *dermatillomania*

Nawracające dłubanie w skórze powodujące uszkodzenia. To zaburzenie psychiatryczne — nie nawyk, nie brak silnej woli. DSM-5 od 2013 r. Skuteczne leczenie istnieje.

CZAS: 10–15 min · psychoedukacja Na początku · zrozumienie zaburzenia

ŹRÓDŁO: DSM-5 (APA 2013, F42.4); Farhat i in. (2023, meta-analiza); Grant i in. (2012)

JAK UŻYWAĆ

Poznaj **kryteria diagnostyczne DSM-5** i **ICD-11** dermatillomanii (sekcja 1), zrozum **dane epidemiologiczne** — kogo dotyczy i jak często (sekcja 2). W sekcji 3 sprawdź **częste współwystępowanie**. Sekcja 4 — przestrzeń na własne notatki.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Farhat i in. (2023, meta-analiza 19 badań, N = 38 038): **3,45% populacji ogólnej** spełnia kryteria dermatillomanii — to znacznie więcej niż się powszechnie sądzi. Częściej u kobiet (iloraz szans 1,45). Początek najczęściej w okresie dojrzewania, przebieg *przewlekły, nawracający*. Mimo tego — diagnoza często stawiana z opóźnieniem 5–15 lat (wstyd, ukrywanie ubraniem, minimalizowanie). DSM-5 (APA, 2013) uznało *excoriation disorder* za pełnoprawne zaburzenie psychiatryczne z grupy obsesyjno-kompulsyjnych i pokrewnych (OCD). To **nie nawyk**, **nie** brak silnej woli, **nie** dziwactwo — to mechanizm neurobiologiczny z udziałem prążkowia (analogia do OCD), regulujący dysregulację emocjonalną i sensoryczną. Walidacja jako zaburzenia **otwiera drogę** do skutecznego leczenia (HRT/CBT, meta-analiza Selles 2016: g = 1,19).

01 Kryteria diagnostyczne — DSM-5 (F42.4) i ICD-11 (6B25.1)

A · POWTARZAJĄCE SIĘ DŁUBANIE

Nawracające dłubanie w skórze powodujące *widoczne uszkodzenia* tkankowe. Drapanie, ściskanie, wyciskanie, wyrywanie strupów.

B · POWTARZANE PRÓBY ZAPRZESTANIA

Wielokrotne nieudane próby *zmniejszenia lub przerwania* dłubania. To różnicuje dermatillomanię od „zwykłego dłubania”.

C · ISTOTNE CIERPIENIE / UPOŚLEDZENIE

Dłubanie powoduje *klinicznie istotne cierpienie* lub upośledza funkcjonowanie — społeczne, zawodowe, w innych obszarach.

D · WYKLUCZENIE INNYCH PRZYCZYN

Nie wynika z działania substancji (np. amfetamina) ani innej choroby (świerzb, atopowe zapalenie). Diagnoza różnicowa kluczowa.

02 Dane epidemiologiczne

3,45% POPULACJI

spełnia kryteria (Farhat 2023, meta-analiza, N = 38 038). To znaczy ok. **1,3 mln osób w Polsce**. Nie jesteś sam/-a.

OR 1,45 (KOBIETY)

Częściej u kobiet, ale mężczyźni też dłubią. Różnica może być częściowo ze wstydu i mniejszego zgłaszania się.

POCZĄTEK: 13–15 LAT

Najczęściej w okresie dojrzewania (zmiany hormonalne, trądzik). Przebieg *przewlekły*, z okresami nasilenia i remisji.

Najczęstsze miejsca dłubania: twarz (60–80%), ramiona, dłonie, nogi, skóra głowy, plecy. Wiele osób dłubie w *kilku* miejscach jednocześnie. Narzędzia: najczęściej własne palce/paznokcie, czasem pęsety, igły — nasilona forma wymaga szczególnej troski o higienę i ryzyko infekcji.

03 Często współwystępowanie

Dermatillomania rzadko występuje samodzielnie. Większość pacjentów ma **jedno lub więcej** współwystępujących zaburzeń — i to też wymaga uwagi, bo każde z nich może *podtrzymywać* dłubanie.

DEPRESJA · 40–70%

Najczęstsze współwystępowanie. Wstyd po dłubaniu + uszkodzenia → izolacja → obniżony nastrój → więcej dłubania jako regulacja emocji.

LĘK · 30–50%

Lęk uogólniony, lęk społeczny. Dłubanie redukuje doraźnie napięcie — jest *nieadaptacyjną* strategią radzenia sobie ze stresem.

OCD · 15–20%

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne. Dermatillomania należy do tej samej rodziny DSM-5 (OCD). Wspólne mechanizmy neurobiologiczne.

INNE BFRB · CZĘSTO

Trichotillomania (wrywanie włosów), onychofagia (obgryzanie paznokci), gryzienie policzków. Wielu pacjentów ma 2–3 BFRB.

04 Moje notatki

OD KIEDY DŁUBIĘ, JAKIE MIEJSCA

— *wiek początku, najczęstsze miejsca, narzędzia*

CZEGO JUŻ PRÓBOWAŁEM/-AM

— *próby zaprzestania, co działało, co nie*

-------------------	-------------------

Klucz: dermatillomania to **nie** nawyk, *nie* brak dyscypliny ani „brzydki zwyczaj”. To **zaburzenie psychiatryczne**, oficjalnie uznane przez DSM-5 od 2013 r. i ICD-11 od 2022 r. (6B25.1). Stein i in. (2010) zidentyfikowali mechanizm neurobiologiczny: dysfunkcja obwodów w prążkowiu (jądra podstawne), te same struktury co w OCD i innych BFRB. To znaczy, że *nie wystarczy „postanowić, że się przestaje”* — potrzebne są **strukturyzowane techniki**. Dobra wiadomość: skuteczne leczenie istnieje. Trening odwracania nawyku (HRT, Azrin & Nunn 1973) ma w meta-analizach wielkość efektu $g \approx 1,1-1,2$ — to *duży efekt*, porównywalny z najlepszymi interwencjami w psychiatrii. Pierwszy krok: uznać, że to jest *problem zdrowotny*, a nie kwestia charakteru.